

る場合が多い。

右左シャント率の上昇によって低酸素血症、チアノーゼ、労作時呼吸困難、横臥呼吸が出現する。またこの右左シャントを経て血栓や細菌が左心系に飛び（奇異性塞栓症）、結果として脳梗塞、脳膿瘍、一過性脳虚血発作などを起こす。さらに瘻の破裂によって血胸や咯血をきたす。

診断・検査

前述のように HHT を合併していることがあるため、家族歴の聴取をはじめ、繰り返す鼻出血、皮膚粘膜血管腫、貧血の有無を確認し、脳動静脈奇形などの他臓器の血管奇形の有無を検索する。

従前は確定診断のために肺動脈造影が施行されていたが、近年では胸部造影 CT で確定診断を行う。

a 画像診断

i) 胸部単純 X 線（図 1a, b）

濃度均一で境界明瞭な円形もしくは楕円形の輪郭が分葉化した結節影を認める。これに流入または流出する血管を示す帯状の陰影を認めることもある。

ii) 胸部 CT

単純 CT では、境界明瞭な分葉化した結節影を認め、それに連続する血管影を認める（図 1e）。造影 CT では肺動脈相で結節および血管の造影効果を認める。

iii) 肺動脈造影

後述のコイル塞栓術の際に行う（図 1d）。この際

CT で診断できない微細な病変を認めることがあるので注意する。肺高血圧症を合併することがあるので、肺動脈圧の測定も同時に行うとよい。

b 右左シャント率の評価

100%酸素を 20 分以上吸入した後、動脈血液ガスを測定し計算する。

肺血流シンチグラムでも、肺と脳・腎臓・甲状腺などの肺外臓器のカウンtr比から計算できる。

治療と予後

治療しないで放置した場合の死亡率は 0~29%とされている。瘻の大きさや右左シャント率は経時的に増悪することや、病変の大きさに関係なく奇異性塞栓を起こす可能性があることから、画像的に肺動静脈瘻と診断しうる病変は大きさに関係なく治療の適応となる^{1,4)}。

従来は外科的切除が行われたが、最近の治療の第一選択は経カテーテル的コイル塞栓術である。なお両肺びまん性の肺動静脈瘻については肺移植も検討する¹⁾。

文 献

- 1) 杉浦寿彦：日本臨床別冊循環器症候群Ⅳ：201, 2020
- 2) Gossage JR, et al : Am J Respir Crit Care Med **158** : 643, 1998
- 3) Cottin V, et al : Am J Respir Crit Care Med **169** : 994, 2004
- 4) Shovlin CL, et al : Thorax **72** : 1154, 2017